ALTAMEDICA
ARTEMISIA

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

Il tuo profilo genetico ha evidenziato

UNA PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLA CARENZA DI VITAMINA D

La Vitamina D è di fondamentale importante per diversi processi: il riassorbimento di calcio e fosforo a livello renale e intestinale, la mineralizzazione dell'osso, la salute cardiovascolare e inoltre regola la produzione e impedisce l'esaurimento di neurotrasmettitori (adrenalina, noradrenalina, dopamina e serotonina), la cui carenza è direttamente connessa allo sviluppo di depressione.

La Vitamina D, all'interno dell'organismo, è trasportata dalla *Proteina Legante la Vitamina D (DBP),* una proteina appartenente alla famiglia genetica dell'albumina umana del siero e dell'alfa – fetoproteina. La troviamo maggiormente all'interno del sangue, a causa dell'elevata concentrazione di Vitamina D. È in grado di trasportare i metaboliti di questa vitamina nella pelle, nel fegato, nei reni e in molti altri tessuti.

La DBP è capace di trasportare tutte le diverse forme della Vitamina D, incluso il prodotto ormonale attivo 1-25, diidrossivitamina D (calcitriolo).
Una *carenza* della sintesi genetica della DBP causa una riduzione della Vitamina D nell'organismo, ovvero una *ipovitaminosi D*.

Oltre che da cause genetiche, la carenza di Vitamina D può dipendere da molti altri fattori, tra cui: un'inadeguata esposizione solare, un insufficiente apporto alimentare della vitamina in questione, la presenza di malattie renali o epatiche, l'assunzione di alcuni specifici farmaci o un aumento del fabbisogno.

Le principali *conseguenze* della carenza di Vitamina D sono il Rachitismo, nei soggetti di giovane e giovanissima età, e l'Osteomalacia e l'Osteoporosi, negli individui adulti.
I medici, per accertarsi di un'eventuale carenza di Vitamina D, ricorrono alle analisi del sangue, in particolare la misurazione dei livelli sanguigni di 1-25 - diidrossicalciferolo (calcidiolo), 1.25 - idrossivitamina D e 1,25-diidrossivitamina D (calcitriolo, la forma attiva).

Il *trattamento* per la carenza di Vitamina D consiste in una terapia causale e in una terapia atta a risollevare nell'immediato i livelli vitaminici carenti.

Consigli alimentari in base al tuo profilo genetico:

Sono strettamente consigliati alimenti ricchi di Vitamina D:
Olio di fegato di merluzzo
Ostriche e gamberi
Pesci grassi come: sgombro, tonno, carpa, salmone, aringa, trota
Tuorlo d'uovo
Funghi e in misura minore verdure a foglia verde
Carne di fegato
Latte intero o yogurt intero
Cacao

Bibliografia

Ganz AB, Park H, Malysheva OV, Caudill MA. *Vitamin D binding protein rs7041 genotype alters vitamin D metabolism in pregnant women.* FASEB J. 2018 Apr;32(4):2012-2020. doi: 10.1096/fj.201700992R. Epub 2018 Jan 5. PMID: 29196501; PMCID: PMC5893171.